

Пликация полового члена

Информация для пациента · Операция по выпрямлению полового члена (болезнь Пейрони)

WARWIKI

При болезни Пейрони внутри полового члена образуется рубцовая бляшка, которая вызывает искривление при эрекции и может затруднять половую жизнь. Пликация выпрямляет искривление: хирург накладывает швы на более длинную сторону члена, слегка «подбирая» её до уровня более короткой. В этом буклете объясняется, как работает операция, как к ней подготовиться и чего ожидать.

Об этой процедуре

При болезни Пейрони рубцовая ткань стягивает одну сторону члена, из-за чего при эрекции он изгибается. Пликация выпрямляет его, ушивая и укорачивая **более длинную (внешнюю) сторону** изгиба до уровня короткой. Рубец не иссекается, трансплантат не используется — это наиболее простая и короткая операция по выпрямлению с **наименьшим риском нарушения эрекции**.

Хороший выбор, если:

- Искривление умеренное, без сложной деформации
- **Эрекция удовлетворительная** (с таблетками или без)
- Длина члена позволяет принять небольшое укорочение

Что важно знать

Основной компромисс — некоторое **укорочение** члена, как правило около 1–2 см. Большинство мужчин преувеличивают этот эффект: после коррекции искривления функциональная прямая длина нередко оказывается не хуже прежней. Примерно **9 из 10** мужчин достигают достаточного выпрямления для половой жизни. Швы могут **прощупываться** под кожей — это обычно и не причиняет неудобств. Цель — достаточно прямой член для комфортного секса, а не идеально ровный.

ТЕРМИНЫ

Болезнь Пейрони

Рубец в половом члене, вызывающий его искривление при эрекции.

Бляшка

Участок рубцовой ткани, создающий искривление.

Пликация

Выпрямление члена путём ушивания и укорочения более длинной стороны.

Искусственная эрекция

Эрекция, вызванная в операционной (инъекцией) для измерения и оценки искривления.

Циркумцизия

Удаление крайней плоти — иногда выполняется одновременно, если ранее не проводилась.

Вакуумное устройство

Помпа, которую иногда используют в период заживления для сохранения длины и поддержки эрекции.

Общая анестезия

Препараты, погружающие вас в сон во время операции.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей, спинальной или местной анестезией, поэтому во время неё вы ничего не чувствуете. После следует ожидать отёка, синяков и болезненности в области члена в течение 1–2 недель — помогают лёд, поддерживающее бельё и обезболивающие. Операция короткая (обычно около часа) и, как правило, выполняется амбулаторно. Катетер может стоять недолго.

Как подготовиться (До операции)

- Операция под **общей, спинальной или местной анестезией** — выполняйте все предоперационные указания (голодание, отмена препаратов, включая антикоагулянты).
- Болезнь Пейрони должна быть **стабильной** (искривление и боль не меняются несколько месяцев) — хирург подтвердит готовность к операции.
- **Не курите**; любая инфекция лечится заранее; вам назначат антибиотики. Если циркумцизия не проводилась, её можно выполнить одновременно — уточните у хирурга.

Заранее сообщите команде, если у вас:

- **Слабая эрекция** или приём препаратов для её поддержания
- Приём антикоагулянтов или ранее перенесённые операции на половом члене

Что происходит во время операции

- 1 Вы находитесь под анестезией; вводятся антибиотики.
- 2 **Инъекцией вызывается эрекция**, чтобы хирург оценил искривление; затем на более длинную сторону накладываются швы для выпрямления.
- 3 Результат проверяется повторной эрекцией; кожа ушивается (при необходимости одновременно выполняется циркумцизия).

После операции

- Ожидайте **отёк, синяки и болезненность** 1–2 недели. Используйте лёд, поддерживающее бельё и обезболивающие.
- Если был установлен катетер, его обычно удаляют утром после операции.
- **Воздерживайтесь от секса около 4–6 недель** для заживления.
- Хирург может назначить **низкодозовый препарат для эрекции** и/или ежедневное применение **вакуумного устройства** в период заживления.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб; нарастающее покраснение, боль, отёк или выделения из раны
- Невозможность помочиться
- Сильный или нарастающий отёк, боль или обильное кровотечение

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Пликация выпрямляет искривление путём ушивания более длинной стороны — без иссечения рубца и без трансплантата. Это наиболее простая операция с наименьшим риском нарушения эрекции.
2. Компромисс — небольшое **укорочение** (обычно 1–2 см), но коррекция искривления нередко восстанавливает функциональную длину; ~9 из 10 мужчин достигают достаточного выпрямления.
3. Болезнь должна быть стабилизирована; не курите. После операции воздерживайтесь от секса ~4–6 недель и соблюдайте план восстановления.